

Control de salud en el primer año de vida

Hospital General de Agudos Dr. Pedro Ecay. Carmen de Patagones.

Autores:

Dra. Cecilia Cuneo.

Médica pediatra. Jefa de residentes Hospital Ecay. Egresada Residencia Clínica Pediátrica. Hospital Ecay. Carmen de Patagones.

Dr. Jonatan M. Vázquez.

Residente 4.º año Clínica Pediátrica Hospital Pedro Ecay. Carmen de Patagones.

Dra. M. Laura Sequeiros.

Residente 3º año Clínica Pediátrica Hospital Pedro Ecay. Carmen de Patagones.

Yolanda G. Aviles Spellman.

Residente 2.º año Clínica Pediátrica Hospital Pedro Ecay. Carmen de Patagones.

Revisora:

Dra. Gabriela S. Sánchez.

Médica pediatra. Instructora de residentes Hospital Ecay.

Egresada Residencia Clínica Pediátrica Hospital de Niños Pedro de Elizalde, CABA.

INTRODUCCIÓN

El control de salud es una actividad dirigida a promover la salud de los niños en forma integral y detectar precoz y oportunamente cualquier anomalía o enfermedad que pudiera presentarse. A través de la supervisión de salud integral, se espera además acompañar el proceso de crecimiento y desarrollo integral de la población infantil y, en el caso de las familias con vulnerabilidad psicosocial, vincularlas con la cadena de servicios existentes tanto en la red asistencial de salud como en las redes comunales.

Los principios orientadores de los controles de salud son los siguientes [1]:

Los niños son sujetos de derecho: La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece un conjunto de derechos que todo niño posee y que le permitirá vivir y desarrollarse plenamente para lograr la mayor expresión de su potencialidad. En el ejercicio de estos, tienen necesidades específicas en materia de cuidados físicos, atención emocional y orientación cuidadosa, así como en lo que se refiere a tiempo y espacio para el juego, la exploración y el aprendizaje social.

La atención es un proceso continuo: La atención de los niños comienza desde la gestación (controles y talleres prenatales: estilos de vida saludables, cuidados prenatales, lactancia materna, etc.), continúa con el nacimiento (acompañamiento de una persona significativa durante el proceso de parto, apego precoz piel a piel, alojamiento conjunto, etc.) y prosigue con el control de salud infantil en APS.

La continuidad del proceso de atención permite desarrollar un vínculo entre la familia, los niños y el equipo de salud.

El seguimiento continuo facilita el desarrollo de un plan de trabajo dinámico, flexible y acorde con las necesidades de cada familia, en el que es posible priorizar, ejecutar y evaluar en forma periódica las dificultades, aprendizajes y logros.

Cada familia y persona es única: Los niños y las familias forman parte de un sistema complejo con dimensiones biopsicosociales y emocionales indisolubles, que interactúan determinando su salud. El desafío para el equipo de salud es adaptar los conocimientos, la evidencia científica y las normativas a cada persona y su entorno, con el fin de lograr los mejores resultados.

Los niños son parte de un contexto social: La salud de una persona está estrechamente vinculada con los determinantes sociales de la salud, tales como nivel socioeconómico, educacional y cultural-familiar, condiciones medioambientales y habitacionales, capacidad para autocuidado en salud que la familia posee y el acceso a los servicios de salud.

El desarrollo infantil temprano es determinante en el bienestar biopsicosocial futuro de cada persona: Los primeros años de vida son críticos para el óptimo desarrollo y expresión de potencialidades de cada uno. En este período existen ventanas únicas para el desarrollo de habilidades emocionales, sociales, motoras, sensoriales, de desarrollo de lenguaje, entre otras. El equipo de salud debe invertir en acompañar y potenciar dichas habilidades desde la gestación hasta los 10 años.

La atención debe ser diferenciada según los problemas detectados: El equipo de salud se verá enfrentado a familias con distinto nivel de vulnerabilidad y tiene el deber de entregar atenciones diferenciadas según los riesgos y factores protectores detectados en cada una. Esto puede condicionar que el rendimiento del control pueda ser mayor o menor a lo indicado en la normativa (aunque el centro de salud debe realizar su programación con los rendimientos estipulados, esto solo es válido a nivel individual).

Privilegiar un enfoque anticipatorio, promocional y preventivo: Los equipos de salud deben estar atentos a desarrollar acciones promocionales y preventivas, según la realidad nacional, de la comunidad, la familia y la persona. Es deber del equipo anticiparse a los posibles problemas de salud y promover acciones dirigidas al desarrollo armónico de los niños y niñas de su comunidad, empoderando al conjunto de la familia en el cuidado de su salud integral.

Cada control es una oportunidad: Las familias son unidades cambiantes y dinámicas, y cada encuentro con el equipo de salud debe considerar el momento que la familia está viviendo y vincularlo a los encuentros anteriores y los avances en el plan de trabajo. Además, en la medida en que los niños y niñas crecen, asisten menos a los centros de salud, por lo que cada encuentro es una ocasión para identificar potenciales riesgos, fortalecer factores protectores y realizar las intervenciones que sean pertinentes a cada familia.

Situación clínica

Tomás, de 1 año de edad, acude a control de salud en el CAPS.

Es un niño sano. No presentó internaciones ni patologías infecciosas relevantes. Usted pregunta sobre antecedentes perinatólogicos:

RNT PAEG. Parto eutócico. Alta médica a las 48 h de vida. Presenta estudios de errores congénitos del metabolismo normales. OEA presentes, vacunas al día.

Usted pregunta a la mamá, mientras desviste al paciente para pesarlo y medirlo, acerca de los hitos madurativos. La mamá refiere que el niño no responde a su nombre cuando lo llaman. No dice "papá" ni "mamá". No dice "chau" con la mano. Ya camina solo. No señala con su dedo para pedir objetos.

El examen físico es normal. Con peso y talla en pc 50. Presenta erupción dentaria acorde a su edad.

Alimentación: Lactancia materna hasta los 6 meses. Toma 2 biberones al día de 250 ml y come variado. Usted decide darle algunos juguetes que tiene en el consultorio y observa su comportamiento, y Tomás comienza a poner uno detrás del otro, sin importarle qué tipo de juguetes son, sin darles ningún valor simbólico. No observa en la consulta indicios de contacto vincular con su madre. Al dirigirse al niño, este parecería ignorarlo, y sigue su motivación por abrir y cerrar las puertas de un pequeño armario con medicamentos. Esta es su primera visita a control y usted detecta algunas dificultades en el desarrollo de Tomás, por lo que comenta a la madre que quiere verlo nuevamente en unos días, donde se tomará un tiempo de consulta más adecuado exclusivamente para evaluar este aspecto que impresiona alterado.

Comentario: La impresión fue correcta. Un adecuado seguimiento permitió un diagnóstico oportuno de trastorno del espectro autista. Tomás inició rápidamente su tratamiento multidisciplinario.

CONTROL DE SALUD DEL NIÑO DE 0 A 6 MESES

FRECUENCIA DE LOS CONTROLES DE SALUD

La recomendación ideal es realizar 13 controles dentro del primer año de vida (10 a 15 días y uno mensual hasta los 12 meses).

Nota del autor, Prof. Dr. Juan Reichenbach: Se recomienda cada 2 meses en el segundo semestre. Quizás la consulta espontánea por afecciones agudas nos acerca a esa cifra final en el año, si es que la usamos además para el control.

Control de salud en el 1.^{er} mes de vida

Objetivos:

- o Orientar a los padres y cuidadores respecto de la salud, desarrollo y cuidado del niño.
- o Observar la interacción entre adultos y recién nacidos.
- o Fomentar la lactancia materna exclusiva y evaluar el estado nutricional.
- o Reafirmar el vínculo de la familia con el centro de salud.
- o Brindar a la familia contenido promocional y de prevención concordante con el período.
- o Pesquisar anomalías o malformaciones y alteraciones del neurodesarrollo.

Durante este período se deben realizar dos controles de salud (10-15 días y 1.^{er} mes).

El nacimiento de todo niño no solo trae consigo un momento de felicidad para la familia, sino también crisis esperables. Se debe afianzar la relación entre el centro de salud y la familia en todo momento para poder responder ante cualquier consulta o inquietud que surja.

En cuanto a la lactancia, tempranamente suelen comenzar problemas como dolor y mala técnica de succión que generan su discontinuidad y abandono. La inmadurez fisiológica del sistema nervioso central hace que el examen físico tenga particularidades que deben contemplarse.

En cuanto al desarrollo, es esperable alcanzar los siguientes logros:

ÁREA	LOGRO ALCANZADO
MOTOR	Levanta el mentón en prono Fija la mirada Gira la cabeza en supino Movimientos aleatorios y simétricos

COMUNICACIÓN	Llanto como señal de comunicación
COGNITIVO	Atento a estímulos
SOCIO-EMOCIONAL	Cuando llora logra calmarse con los padres

Anamnesis control de salud 1.º mes

Antecedentes materno-obstétricos: gestación, parto y puerperio.

Antecedentes neonatales:

Antropométricos y vitalidad fetal: peso nacimiento; al alta: talla, PC, valoración Apgar.

Infectológicos: pesquisa infectológica durante el embarazo.

Alimentación: lactancia materna exclusiva o si requirió apoyo nutricional (glucosado, fórmula de inicio, eventual PHP).

Presencia de problemas durante la gestación, parto o internación del binomio madre-hijo.

Evaluar *screening* de alta neonatal:

Errores congénitos del metabolismo.

Screening auditivo.

Vacunas (HVB y BCG).

Inscripción al Registro Civil.

Alimentación actual y su frecuencia: lactancia exclusiva o si requiere apoyo nutricional complementario. En cuanto a la frecuencia, si toma a demanda o con tiempo fijo, si solicita alimentarse o hay que despertarlo. Consultar por presencia de dificultades (dolor, tumefacción, mala técnica, imposibilidad laboral, etc.) y si cuenta con algún apoyo para la crianza. Siempre se debe observar la técnica alimentaria para comprobar el acople y la succión durante esta.

Llanto del niño, interpretación y posibilidad de consuelo.

Antecedentes familiares de importancia: cardiopatías, patología luxante de cadera, trastornos sensoriales, neoplasias pediátricas, ambiopía, estrabismo.

Examen clínico integral durante el control de salud en el 1.º mes

Aspecto general del niño: color de la piel, evidencia de malformaciones, postura y tono muscular.

Relación con sus padres: evaluar si el niño fija la mirada, responde ante el habla de sus padres, sonrisa social (puede no estar presente), logra ser consolado ante el llanto.

Piel: evaluar color, ictericia, eritemas, hemangiomas, manchas hipocrómicas y, ante su presencia, observar distribución, tamaño, número, aspecto.

Oftalmológico: simetría ocular, existencia de estrabismo, reflejo pupilar y presencia de leucocoria.

Bucodental: fisura palatina, dientes connatales, frenillo sublingual (su papel en lactancia materna).

Neurológico: evaluar tono muscular y postura, palpar fontanelas (tamaño, tensión), tamaño y forma craneal (cefalohematoma, caput), reflejos arcaicos, presencia y simetría.

Tórax y cardiopulmonar: simetría torácica, presencia de soplos y/o ruidos patológicos, pulsos femorales y braquiales, presencia y simetría.

Abdominal: evaluar en el cordón umbilical signos de infección, masas palpables, hernias.

Extremidades y columna: simetría, búsqueda de signos tempranos de patología luxante de cadera (signos de Ortolani y Barlow). Fosita pilonidal o defectos del cierre de la columna (hemangiomas, manchas, fositas, etc.).

Genitourinario: permeabilidad del ano; en el caso de los varones, evaluar presencia de testículos en escroto y descartar epi o hipospadias, como así también presencia de hernias.

Antropometría: talla.

Perímetro cefálico: recordar que puede sufrir cambios por la remodelación craneal.

Peso: evaluar ganancia ponderal con peso al alta, recordar que los niños pueden perder un 10% de peso durante los primeros días de vida para recuperarlo dentro de los 14 días posteriores. Si es

necesario, citar al paciente en 24-48 h para control de peso y evaluar ganancia ponderal (mínimo 20 g/día).

PAUTAS DE ALARMA

ASPECTO		
ALIMENTACIÓN	FALLA LACTANCIA MATERNA	Evaluar motivos y entregar propuestas para ayudar.
		Apoyo familiar, considerar aspecto biosocial y cultural.
	RETRASO PONDERAL	Citar a las 48 h, descartar mala técnica, variaciones fisiológicas y patológicas. De persistir, considerar apoyo nutricional complementario.
BUCODENTAL	DIENTES CONNATALES	Derivar al odontólogo.
OFTALMOLÓGICO	LEUCOCORIA O ESTRABISMO	Derivar al oftalmólogo.
CARDIOPULMONAR	SOPLOS O RUIDOS AGREGADOS	Derivar al cardiólogo infantil para evaluación y ecocardiograma.
AUDITIVA	PESQUISA ALTERADA	Considerar repetir OEA y ante negatividad realizar PAE.
PIEL	ICTERICIA	Considerar control, según el caso, transcutáneo o central.
SIGNOS DE ENFERMEDAD	Fiebre, cianosis, signos de dificultad respiratoria, de deshidratación u otra de gravedad	Considerar según el caso.
	MANCHAS HIPOCRÓMICAS	Según el caso derivar a neurólogo infantil.
VÍNCULO MADRE-HIJO	TRASTORNOS VINCULARES, EMOCIONALES	Reforzar el contacto piel a piel, incentivar a la familia para la alimentación, buscar un referente de apoyo, fortalecer la relación con el centro de salud.

Puericultura en el 1.º control de salud

Fomento del vínculo de apego madre-hijo: lactancia materna, contacto piel a piel.

Sueño seguro: lecho distinto del de los padres, posición supina, sin presencia de juguetes o peluches, ropa de cama por debajo de axilas (brazos por fuera), posición 30° del lecho de descanso. Ambiente libre de humo y combustión incompleta (ventilar los ambientes diariamente).

Higiene corporal diaria: evitar mojar cordón umbilical mientras este se encuentre presente. Uso de jabón neutro, sin perfumes, temperatura agua templada (37° C), brindar apoyo axial durante el baño.

Cuidado de la piel: no colocar cremas, ni perfumes. Evitar exposición solar.

Prevención de enfermedades: evitar ambientes mal ventilados o muy concurridos y el contacto con personas enfermas, no exponer al humo de tabaco, lavado de manos previo contacto con el niño.

CONTROL DE SALUD EN EL NIÑO DEL 2.º A 6.º MES DE VIDA

Objetivos:

- Realizar una evaluación integral del desarrollo y crecimiento del niño.
- Orientar a los padres o cuidadores sobre desarrollo, y salud de los niños.
- Fomentar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y luego complementaria.
- Recomendaciones sobre alimentación complementaria y suplementos nutricionales.

Durante este período el niño comienza a vocalizar, a reírse, a usar sus manos en forma progresiva y a disfrutar de las sensaciones que le provocan los estímulos bucales, visuales, auditivos. El

control axial y cefálico comienza a ser cada vez mayor y le permiten al niño lograr el sostén cefálico, rolar por sí solo y posiblemente adoptar la sedestación al final de este período.

Durante esta etapa, es esperable alcanzar las siguientes pautas de desarrollo:

ÁREA	2 a 3 MESES	4 y 5 MESES
MOTOR GRUESO	Prono: levanta la cabeza 45°. Supino: levanta los pies y patalea. Supinación ventral: cabeza en línea con el tronco. Movimientos simétricos. Apoyo simétrico de codos en decúbito prono.	Prono: levanta la cabeza y tronco apoyándose en antebrazos. Gira de prono a supino (desde los 4 meses). Supino: intenta sentarse y gira de supino a prono (desde los 5 meses). Empieza a liberar un brazo para alcanzar un objeto que le interese.
MOTOR FINO	Sigue objetos pasando la línea media. Mantiene manos abiertas, las junta en la línea media.	Sigue objetos con la mirada 180°. Toma objetos colgantes y los lleva a la boca (4 meses). Golpea objetos contra la mesa. Coordinación mano-mano-boca.
COGNITIVO	Expresa interés y observa los cambios en el entorno. Explora el ambiente con su mirada, atención y audición. Mira rostros intencionalmente. Repite movimientos para ensayarlos y manejarlos.	Responde al afecto y reacciones en el ambiente. Expresa placer y desagrado. Sigue con la mirada un objeto o persona que pasa por delante de sus ojos. Cambia la mirada de un objeto a otro.
COMUNICACIÓN	Sonrisa social (debe estar presente a las 6 semanas). Vocaliza algunos sonidos ("ah", "eh", "ugh"). Presenta distintos tipos de llantos según el motivo (hambre, malestar, cansancio).	Gira hacia un sonido y voz, dice "agu", gorjea (4 meses) y hace sonidos con "rrr" (5 meses). Percibe un sonido ambiental y busca su procedencia sin soltar o dejar lo que tiene en las manos girando la cabeza o incluso el tronco.
SOCIOEMOCIONAL	Reconoce y se calma al escuchar voces de sus cuidadores. Sonríe al estímulo de los padres. Reconoce a su madre, padre y/o cuidador. Disfruta llevando cosas a su boca.	Sonrisa espontánea (a carcajadas). Se interesa por su imagen en el espejo.

Cuadro 2: Pautas madurativas del niño entre 2 y 6 meses ².

Anamnesis en los controles de salud de 2 a 6 meses de vida

La familia en general ya llega a conocer mejor al niño, logra distinguir los llantos (hambre, incomodidad) y consolarlo, como así también atender sus necesidades. No obstante, es importante consultar por la presencia de dificultades que aún continúen surgiendo al respecto, como así también afianzar el vínculo con la familia.

Se debe interrogar sobre la alimentación, el tipo (lactancia materna o complementaria), la frecuencia y si el niño la solicita por sí solo o es necesario despertarlo. Dolor o incomodidad materna durante esta. En caso de estar recibiendo suplementos nutricionales (vitamina D, hierro), si tiene alguna dificultad en la administración. Consultar por reinicio de actividad laboral materna para brindar recomendaciones sobre extracción y conservación de leche para poder continuar con la lactancia materna.

Frecuencia y apariencia de orina y deposiciones.

Características del sueño (duración, ambiente).

Consultar sobre la realización de los estudios de *screening* (enfermedades endócrino-metabólicas, otoemisiones acústicas, fondo de ojo, ecografía de caderas) e inquietudes sensoriales (dificultades en la visión o escucha del niño).

Vacunación (ver cuadro adjunto).

Examen clínico integral durante el control de salud de 2 a 6 meses de vida

Relación madre-padre-hijo: evaluar el cuidado y cariño para con el niño, cómo lo toman, lo desvisten y le hablan. Asegurarse de que los padres respondan ante el llanto y puedan consolarlo. Ver si el niño gira la cabeza buscando la vista de los padres o ante el sonido de su voz. Búsqueda de signos de maltrato físico.

Piel: determinar, en el caso de que exista alguna lesión, su número, extensión y características. Confirmar la presencia de reacción de BCG, dermatitis atópica, del pañal, de contacto.

Bucodental: presencia de erupción dental cercana al 6.º mes en algunos niños.

Cardiopulmonar: auscultación cardíaca en búsqueda de ruidos anormales o soplos, arritmias, signos de cardiopatía (como cianosis). Evaluar el aspecto del tórax y la mecánica respiratoria, como así también la presencia de murmullo vesicular y eventualmente de ruidos agregados.

Abdominal: presencia de masas abdominales, hernias, distensión abdominal.

Genitourinario: genitales con caracteres sexuales masculinos o femeninos bien definidos. En mujeres descartar sinequias vulvares, y en varones evaluar la localización testicular y el hidrocele fisiológico.

Ortopedia: maniobras de Ortolani y Barlow, simetría de extremidades y pliegues, aducción y abducción de caderas.

Neurológico: evaluar posición de los pulgares, tono muscular, reflejos arcaicos (presencia y simetría) y su extinción. Tamaño y permeabilidad fontanelar (cierre a los 2 meses de fontanela posterior).

Oftalmológico: presencia de epífora o secreciones, estrabismo, fijación de mirada y seguimiento de esta ante objetos.

Auditivo: reacción ante estímulos sonoros; si observa a quien le habla o gira la cabeza en dirección al sonido.

Antropometría: talla, perímetro cefálico (macro o microcefalia) y peso. Evaluar progresión en curva de crecimiento y eventual reencarrilamiento genético.

PAUTAS DE ALARMA

PROGRESO PONDERAL DISCORDANTE	Evaluar técnica alimentaria, considerar eventualmente alimentación suplementaria.
LACTANCIA MATERNA	Evaluar los motivos por los cuales no se está amamantando y brindar acompañamiento y orientación.
NIÑOS POCO CONSOLABLES	Descartar causa orgánica.
SIGNOS DE MALTRATO	Brindar protección e iniciar la activación del sistema legal correspondiente.
EXAMEN NEUROLÓGICO ALTERADO	Derivación neurología infantil.
PRESENCIA DE SIGNOS DE ENFERMEDAD	Considerar la afección y brindar tratamiento oportuno y seguimiento posterior.
LEUCOCORIA	Derivación con urgencia a oftalmología
PIEL	6 o más manchas café con leche o familiar de primer grado con neurofibromatosis tipo 1 (derivar neurología). Hemangiomas: más de 5, complicados o en zonas especiales (derivar a dermatología). Dermatitis atópica: baños con agua tibia y cortos.
HIPOACUSIA CONFIRMADA	Derivar a otorrinolaringólogo.
DISPLASIA CONGÉNITA DEL DESARROLLO DE CADERA	Derivar a ortopedista,

Puericultura e indicaciones durante los controles de salud del 2.º a 6.º mes de vida

Fortalecimiento de vínculo madre-padre-hijo

Promover la lactancia materna exclusiva. Consultar a la familia sobre la reinserción laboral materna y brindar pautas de extracción y conservación segura de leche. En caso de que comience a trabajar la madre, puede extraerse leche en un ambiente limpio y seguro para que otra persona pueda en su ausencia dar su leche al niño. Al momento de extraerse la leche, debe asegurarse la higiene de manos y de todos los utensilios por utilizar. Una vez extraída, se debe rotular el recipiente contenedor con fecha para así saber el tiempo de vencimiento de la leche según el medio de conservación (ver cuadro). En caso de que esta se encuentre en *freezer* o congelador se debe descongelar a baño María (no a fuego directo) o bajo chorro de agua caliente, nunca en microondas.

MEDIO DE CONSERVACIÓN	TIEMPO DE DURACIÓN
AMBIENTE	8 h
HELADERA (no en puerta)	3 días
CONGELADOR	2 semanas
FREEZER	3 a 4 meses

Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y luego complementaria hasta los 2 años (respetando decisión familiar y condiciones culturales).

Ofrecer alimentos complementarios a partir del 6.º mes de vida. Orientar a los padres en la preparación y contenidos de la dieta, como así también en la manipulación segura de los alimentos durante su preparación (contaminación cruzada con carnes crudas; sobre todo de aquellos alimentos que serán ingeridos sin cocción, preservar la cadena de frío; higiene de manos antes y después de la preparación).

Recaltar la importancia del NO uso de sal y azúcar, ofrecer agua segura (no bebidas gaseosas o azucaradas) o jugos naturales.

Anticiparse a la angustia normal que genera el comienzo de la alimentación complementaria (variabilidad de apetito, protrusión lingual, etc.).

Recomendar que el momento de alimentación sea en un clima de armonía, de reunión familiar.

Solicitar el *screening* por ecografía o radiografía para descartar *displasia del desarrollo de cadera*, según factores de riesgo y disponibilidad de recursos humanos y técnicos.

Screening de hipoacusia por medio de otoemisiones acústicas (OEA).

Comprobar la realización de *screening* para enfermedades endócrino-metabólicas.

Colocar las *vacunas* según calendario de vacunación vigente (ver cuadro).

Suplementos nutricionales:

- Vitamina D: comenzar en el niño de 2 meses con dosis profiláctica de 400 UI día y finalizar a los 6 meses.
- Hierro: la dosis profiláctica es de 1 mg/kg/día de hierro elemental. El preparado recomendado es el sulfato ferroso. Se aconseja comenzar a partir del 4.º al 6.º mes de vida y se extenderá hasta los 12-18 meses. No debe pasarse por alto que debe tomarse 30 min o 2 h después de las comidas.

Medidas promocionales y preventivas sobre incidentes domésticos: colocación y uso adecuado de dispositivos para traslado en vehículos, medidas preventivas de muerte súbita, no exponer al sol, prevención de caídas, golpes o quemaduras.

Fomentar hábitos saludables: baño diario, sueño diurno y nocturno adecuado, reforzar higiene adecuada para cambio de pañal a fin de evitar dermatitis.

Desarrollo motor: importancia de la posición supina sobre superficies duras para el fortalecimiento de la musculatura axial y adquisición de las sucesivas etapas del desarrollo motor. Brindar para ello tiempo y espacio adecuado. A medida que el niño crece, se pueden incorporar juguetes adecuados para su percepción, manipulación y seguridad.

Lenguaje: estimular por medio de sonidos suaves o ruidos que el niño emita, repetirlos, hablarle, cantar canciones. Buscar la interacción por medio de la mirada. Anticiparle por medio del habla todas las acciones que se irán realizando.

CONTROL DE SALUD DEL NIÑO DE 6 A 12 MESES

La frecuencia pautada de controles será mensual en algunos casos y bimensual en los niños sanos sin patología y en ausencia de condiciones adversas asociadas.

Control de salud del niño entre los 6 y los 12 meses

Objetivos:

- Fomentar la lactancia materna exclusiva hasta cumplidos los 6 meses de vida y complementada hasta los 2 años o más.
- Indicar la alimentación complementaria no láctea a partir de los 6 meses de vida, saludable y balanceada considerando las particularidades del lactante y familiares.
- Promover hábitos de alimentación saludable y actividad física diaria a nivel familiar.
- Prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos con la promoción de hábitos de higiene y manipulación de alimentos en el hogar.
- Anticipar a la familia la reacción normal de los niños frente a la alimentación complementaria: huelgas de lactancia, neofobias, variabilidad del apetito, preferencias alimentarias, reflejo de extrusión, entre otras.
- Prevención de intoxicaciones, accidentes y lesiones no intencionales en el hogar.

En este período, el lactante comienza a ver el mundo desde nuevas perspectivas. Al comienzo del período, logra sentarse por algunos segundos y, al final de este, generalmente comienza el desplazamiento independiente, ya sea gateando (fase opcional del desarrollo) o dando sus primeros pasos con o sin apoyo, lo que aumenta su independencia. Esto también implica mayor cuidado de los padres para la prevención de accidentes, quienes deben establecer medidas de seguridad a cada edad orientados por el médico de cabecera.

En esta etapa también existe un gran desarrollo socioemocional que permite una mayor interacción con el mundo exterior, se fortalece la figura de apego y comienza el desconocimiento de los extraños. En el período cercano a los 9 o 10 meses, comienza la angustia de separación, pauta que debe advertirse a los padres para comprender el **Cuadro 3: “Pautas madurativas niños de 6-12 meses”**.²

Comportamiento del niño: En la comunicación también existe un salto muy considerable, ya que los niños están muy interesados en poder expresarse y entender a quienes les rodean. Es frecuente que en este período comiencen a hacer señas como parte del lenguaje no verbal y

	6 a 7 meses	8 a 9 meses	10 a 11 meses
Motor grueso	- <u>En prono</u>: se mueve hacia adelante y atrás. - <u>En supino</u>: lleva los pies a la boca. - <u>Paracaídas lateral</u> - <u>Sedestación</u>: se sienta sin apoyo por segundos o logra sentarse en posición de trípode. - Flexa las rodillas con energía al ponerle de pie.	- Sedestación independiente (7-8 meses). - Gatea o se arrastra (9 meses). - Intenta sentarse estando en supino.	- Da sus primeros pasos con apoyo (10 meses) - Paracaídas horizontal. - Marcha lateral (en posición bípeda, afirmado de algo se desplaza lateralmente).
Motor fino	- Toma objetos con la palma de la mano. - Transfiere objetos de una mano a la otra. - Coordina mano - pie - boca (7 meses)	- Toma 2 cubos con pinza intermedia (término lateral). - Golpea objetos entre sí. - Busca un objeto que cayó en silencio.	- Lanza objetos con intención. - Revuelve con cuchara.
Cognitivo	- Explora el mundo a través de la vista y llevándose los objetos a la boca.	- Desarrolla concepto de permanencia del objeto. - Aprende juegos interactivos. - Distingue continente de contenido (entienden que hay cosas dentro de otras).	- Realiza acciones de autoayuda (toma de un vaso ayudado por otro-10 meses-, ayuda a vestirse-11 meses-). - Comprende conceptos simples de causalidad y efecto (encuentra un objeto debajo de una taza o paño).
Comunicación	- Balbucea y vocaliza. - Reconoce su nombre. - Se gira a la voz.	- Dice disílabos (da-da, pa-pa, ma-ma) inespecíficos. - Imita sonidos. - Hace adiós con la mano y aplaude (9 meses).	- Dice la primera palabra (11 meses), dice papá específico. - Entiende concepto del “no”. - Baila con rebote al son de la música.
Socio-emocional	- Es sociable, interactúa con sus padres. - Reconoce rostros familiares. - Comienza a desconocer a extraños (7 meses)	- Se muestra aprensivo con extraños, los desconoce. - Busca a sus padres como fuente de juego y resguardo. - Ansiedad de separación.	- Siente miedo. - Mirada preferencial a su nombre. - Pide ayuda.

también que comiencen a pronunciar bisílabos para finalmente decir sus primeras palabras.

Anamnesis control de salud del niño mayor de 6 meses

Revisar libreta de salud y controlar carnet de vacunas al día.

Antecedentes patológicos desde el último control.

Consultar sobre dudas de la madre, padre y/o cuidadores principales.

Conversar acerca de cómo ha estado la familia, cómo ha sido la introducción de alimentos complementarios a la leche materna.

Si la madre volvió a trabajar, preguntar si mantiene la lactancia materna y si el lugar de trabajo cuenta con las condiciones (instalaciones o permisos) adecuadas para el amamantamiento.

Características del sueño del niño o la niña.

Frecuencia y apariencia de orina y deposiciones.

Preguntar sobre qué medidas de seguridad tienen con el niño o la niña en casa y al salir en transporte público o en auto.

Examen clínico integral del niño mayor de 6 meses

Antropometría: Medición de longitud. Medición de peso. Medición de perímetro craneano, determinar la existencia de macrocefalia o microcefalia.

Palpar fontanela anterior presente.

Registrar los puntos de peso, talla y perímetro craneano en curvas de crecimiento de la OMS y percentilar.

Examen físico completo.

Piel: Si hubiera hemangiomas, angiomas línea media, periorificiales o nevos, describir apariencia, tamaño y ubicación en la ficha clínica. Si hubiera manchas de color café con leche o hipocrómicas, describir apariencia, número, tamaño y ubicación en ficha clínica. Descartar dermatitis de contacto, atópica, micótica o del pañal.

Ganglios: Presencia de adenopatías, caracterización de la o las adenopatías (ubicación, tamaño, consistencia, movilidad, piel circundante con signos de inflamación, sensibilidad, solitarias o agrupadas), búsqueda de signos clínicos de compromiso hematológico (palidez o petequias o equimosis) y hepato o esplenomegalia.

Cardiopulmonar: Auscultación cardíaca. Auscultación pulmonar. Pulsos periféricos. Tensión arterial. Frecuencia respiratoria.

Abdomen Presencia de visceromegalia o hernias (especialmente inguinales). Descartar masas palpables.

Genital: Niñas: descartar sinequias vulvares. Niños: presencia de ambos testículos palpables en el escroto (descartar criptorquidia) y evaluar hidrocele fisiológico.

Neurológico: Evaluar tono y movilidad. Descartar hipotonía o hipertonia marcada. Ausencia de clonus y/o hiperreflexia. Simetrías en la movilización de extremidades y en los reflejos. Evaluar reflejos. Ausencia de reflejos arcaicos (Moro puede persistir en forma normal hasta los 6 meses).

Bucodental: Examinar labios, mucosa bucal y cara interna de mejillas, encías, lengua y piso de boca.

Evaluar erupción de dientes incisivos (en promedio erupcionan a los 7 meses). Si se produce inicio de la dentición: indicar higiene local y primer contacto con odontopediatra.

Descartar placas blanquecinas (*muguet*).

Recomendaciones

Alimentación (para detalles ver *Guías de Alimentación* del Ministerio de Salud de la Nación)

6 meses: Lactancia materna. Incorporar 1 comida diaria: papillas de harinas, carnes bien cocidas (pollo-vaca-hígado-cerdo), pulpas o jugos de frutas y hortalizas cocidas, adicionar aceite vegetal, evitar la SAL y la MIEL, controlar los azúcares simples.

8 meses: 3 comidas al día y continuar con la lactancia. Incorporar papillas con harina de trigo, legumbres bien cocidas y sin envoltura, yema de huevo.

10-12 meses: Lactancia materna más 4 comidas diarias. Incorporar huevo entero, frutas frescas, vegetales crudos, pescado.

Desde el año, dieta variada.

Manipulación higiénica de los alimentos.

Cocinar bien las carnes.

Durante los 2 primeros años, no se debe restringir la ingesta grasa.

Fomentar el ambiente libre de humo.

Lavar las manos regularmente.

Planificación del espacio físico para prevenir accidentes.

Estimular con cantos, cuentos, relatos. El niño necesita que jueguen con él, salir a pasear, ir a la plaza, visitar a su familia.

Consejería de planificación familiar.

Recomendaciones sobre protectores solares y repelentes.

SIGNOS DE ALARMA

Consultar al médico si:

Fiebre, llanto inconsolable, irritabilidad, decaimiento, falta de apetito, cambios en la coloración de la piel, fatiga, dificultad para respirar, somnolencia, vómitos, diarrea, palidez, temblores focalizados o generalizados.

Pautas para estímulo del desarrollo integral del niño menor de 1 año

Emocional: Recomendarles hacer conexiones emocionales con su hijo o hija a través de gestos, contacto físico y visual.

Indicar hacer de las rutinas diarias una instancia de intercambio afectivo.

Recomendar a la madre o padre preguntar al niño o niña sobre lo que necesita y lo que le pasa.

Indicar al padre o madre que otorguen seguridad al niño o niña mediante el contacto visual, físico y verbal ante la presencia de extraños o situaciones nuevas.

Recordar a la madre o padre que el llanto es una parte importante del desarrollo socioemocional.

Cuando el llanto persista a pesar de ser atendido adecuadamente, fomentar el consuelo efectivo, la interacción cara a cara con el bebé, hablarle suavemente, mecerlo, etc.

Motor grueso: Permitirle al niño estar en prono sobre una superficie firme como la goma eva y dejar juguetes a su alcance para que pueda tomarlos y explorarlos.

Permitirle girar y en forma progresiva comenzar a sentarse.

Sentarlo a ratos sobre el suelo, colocando cojines en su espalda y separando sus piernas para mayor estabilidad.

Mientras juega al caballito o lo mece, suavemente inclinarlo o alterar su equilibrio para que corrija su postura corporal.

Darle la libertad para que se desplace y explore de manera segura (ejemplo: sobre goma eva).

A partir de los 8 meses, estando sentado, tomarlo de los brazos para que intente pararse.

Motor fino: Cuando el niño tenga un juguete en cada mano, ofrecerle un tercer juguete: aprenderá a intercambiar uno por otro.
Durante la comida, colocar pequeños trozos de comida en la mesa.
Ofrecerle una cuchara con comidas blandas, como puré, para que comience a alimentarse solo.

Lenguaje

Sentarlo en una silla alta con medidas de seguridad para que explore visualmente el ambiente e interactúe con otros miembros de la familia.
Aprovechar las actividades rutinarias para leer, cantar, tocar música e imitar vocalizaciones.
Mostrarle libros con figuras de animales llamándolos por su nombre, mostrarle fotos de familiares cercanos llamándolos por su nombre.
Enseñarle a decir “adiós” al despedirse.
Se pueden enseñar señas para las palabras de uso común para facilitar la comunicación con el niño o la niña y fomentar el lenguaje. Esta práctica no desincentiva el lenguaje, sino todo lo contrario, pues fomenta el desarrollo del lenguaje preverbal. El niño comenzará a realizar señas a partir del mes 10 aproximadamente.

Concepto de permanencia: Con el niño o la niña sentada frente a una mesa, colocar un juguete sobre esta y luego hacer que se caiga, así aprenderá a anticipar la caída y a buscar el objeto perdido.

Jugar a “¿Dónde está? ¡Ahí está!”. Taparse parte de la cara, esconderse detrás de un mueble, esconder un objeto bajo una frazada o colocar un objeto bajo una taza invertida, para que el niño o la niña lo encuentre.

Juego interactivo: Experimentar con distintas texturas y temperaturas (hielo, agua tibia, goma, plástico, algodón).

Anexo

Consideraciones especiales en el control de salud

Calendario de vacunación 2017 hasta los 12 meses

Vacunas	BCG	Hepatitis B	Neumococo conjugada	Quíntuple pentavalente DPT-HB-Hib	Polio: IPV	Polio: OPV	Rotavirus	Meningococo	Gripe	Hepatitis A	Triple viral
Recién nacido	Única dosis (A)	Dosis neonatal (B)									
2 meses			1. ^a dosis	1. ^a dosis	1. ^a dosis		1. ^a dosis (D)				
3 meses								1. ^a dosis			
4 meses			2. ^a dosis	2. ^a dosis	2. ^a dosis		2. ^a dosis (E)				
5 meses								2. ^a dosis			
6 meses				3. ^a dosis		3. ^a dosis			Dosis		

12 meses			Refuerzo						Anual (F)	Única dosis	1. ^a dosis
-------------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--------------	----------------	--------------------------

(A) Antes de egresar de la maternidad.

(B) En las primeras 12 horas de vida.

(D) La 1.^a dosis debe administrarse antes de las 14 semanas y 6 días o 3 meses y medio.

(E) La 2.^a dosis debe administrarse antes de las 24 semanas o los 6 meses de vida.

(F) Anual se aplica entre los 6 y los 24 meses. Deberán recibir en la primovacunación 2 dosis de la vacuna separadas al menos por 4 semanas.

Evaluación oftalmológica

Antecedentes de importancia que requieren evaluación del especialista

1. Recién nacido prematuro, especialmente los de menos de 1500 gramos de peso al nacimiento.
2. Historia familiar de retinoblastoma, catarata congénita o glaucoma congénito.
3. Familiar cercano con ceguera o visión subnormal de causa no traumática.
4. Ametropías de altas de padre, madre, hermanos, hermanas (uso de lentes de potencia alta).
5. Síndromes genéticos (síndrome de Down).
6. Traumas craneofaciales.
7. Enfermedades sistémicas: síndrome de Marfan, neurofibromatosis, síndrome de Sturge Weber, etc.
8. Diabetes mellitus tipo 1, especialmente después de la pubertad.

Reflejo rojo

Es un examen que debe ser conocido y practicado por todos los profesionales de la salud que realizan controles a niños y niñas, en cada control hasta los 3 años.

Es sencillo de realizar e importante para detectar alteraciones del reflejo rojo pupilar (reflejo opaco o blanco) en uno o ambos ojos por compromiso de las estructuras transparentes del ojo como córnea, cristalino, humor vítreo.

La forma de realizarlo es en penumbras o con poca luz, y se espera a que el niño esté con los ojos abiertos. Encontrándose el examinador a una distancia de aproximadamente 50 cm, ilumina ambos ojos en simultáneo con oftalmoscopio, un otoscopio sin ventana o linterna, y observa un reflejo rojo pupilar normal de ambas pupilas expuestas a la luz, una tonalidad roja anaranjada, con el mismo efecto de "ojo rojo" que aparece en algunas fotos con flash.

Esto es muchas veces motivo de consulta de los padres por notar asimetría del reflejo al tomar la foto.

Permite pesquisar diferentes patologías como:

- cataratas congénitas
- estrabismo
- glaucoma infantil
- vicios de refracción
- hemorragia vítrea
- Tumores intraoculares (como retinoblastoma).

Se instaure así un tratamiento oportuno que modifica radicalmente la vida del paciente.

Evaluación ortopédica

En la anamnesis, dependiendo de la edad del niño, se debe preguntar a los padres sobre la existencia de dolor referido o dificultad para usar alguna parte de su cuerpo: falta de fuerza en las extremidades, claudicación de la marcha (desde el inicio de la marcha bípeda). Preguntar si existen asimetrías detectadas.

El examen físico debe ser completo con el niño/a sin ropa (o en ropa interior): se deben descartar asimetrías corporales, inspeccionar las caderas, observar la marcha cuando ya caminan y valorar los rangos de movilidad articular.

Al inspeccionar las caderas, descartar los siguientes signos:

- **Limitación de la abducción:** Al abrir la pierna como un libro no sobrepasa los 60°.
- **Signo de Ortolani positivo:** Con el niño/a en decúbito supino y con las caderas flexionadas en ángulo recto se apoya el pulgar en la cara interna del muslo y el dedo medio a nivel del trocánter mayor. Al abducir (alejar de la línea media) se siente un “clic” de entrada de la cabeza del fémur en el acetábulo.
- **Signo de Barlow positivo:** Con el niño/a en decúbito supino y con las caderas flexionadas en ángulo recto, se apoya el pulgar en la cara interna del muslo y el dedo medio a nivel del trocánter mayor. Al aducir (aproximar a la línea media) se siente un “clic” de entrada de la cabeza del fémur en el acetábulo.
- **Signo de Galeazzi:** Acostado con muslos en ángulo recto se aprecia altura distinta de las rodillas.

La displasia del desarrollo de la cadera:

Es una alteración del desarrollo de la cadera y puede tener distintos grados, desde una displasia del acetábulo hasta una luxación de la cadera.

Los signos tardíos de displasia de cadera son claudicación (cojera) o marcha de pato. No se retarda el inicio de la marcha.

Cuando existan factores de riesgo o un examen físico alterado y luego de realizar ecografía de caderas o radiografía de caderas (según corresponda), derivar al traumatólogo infantil.

Factores predisponentes para la displasia del desarrollo de la cadera:

1. antecedentes familiares en primer grado,
2. sexo femenino,
3. presentación podálica,
4. oligohidramnios,
5. primigesta,
6. neonato macrosómico,
7. embarazo múltiple,
8. otros problemas congénitos: pie talo, torticollis, metatarso varo.

Evaluación auditiva ¹¹

En Argentina, a través de la Ley 25415 se estableció el derecho de todo recién nacido a que se le estudie su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento de forma oportuna si lo necesitara. Considerando que la detección temprana de la hipoacusia es una medida muy eficaz desde el punto de vista de la prevención, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia prioriza la realización de la pesquisa en forma universal.

Este hecho obliga a una conducta activa en el control de salud infantil, para estar alerta frente a cualquier hecho que pudiera relacionarse a una hipoacusia aún no diagnosticada. Se ha demostrado que el diagnóstico precoz (menor de tres meses, ideal antes del alta de la maternidad), la implementación temprana de tratamiento con prótesis auditivas bilaterales (antes de los seis meses) y un seguimiento apropiado que incluya calibración de los audífonos y educación al grupo familiar permiten que niños y niñas hipoacúsicos se desarrollen en forma similar a sus pares normoyentes o de acuerdo con su nivel cognitivo.

Acciones que orientan a la pesquisa de hipoacusia durante el control de salud infantil

En el examen de salud infantil, se debe descartar sospecha de hipoacusia recolectando información tanto de la anamnesis como del examen físico.

La hipoacusia neonatal es generalmente de origen sensorineural. Un 50% tiene alguna causa genética conocida, con un 70% de sordera no sindrómica. Entre las causas no genéticas neonatales están las infecciones congénitas, hiperbilirrubinemia y medicamentos ototóxicos.

En la **anamnesis** se debe indagar acerca de **factores de riesgo de hipoacusia** en el recién nacido. Se reconoce que un 50% de los niños y niñas con hipoacusia tiene alguno de estos factores:

- Permanencia por más de cinco días en UCI/UTI neonatal.
- Infecciones neonatales (citomegalovirus, toxoplasmosis, meningitis bacteriana, sífilis, rubeola, virus herpes) o infecciones durante el período de lactante (meningitis bacteriana o viral).
- Alteraciones craneofaciales, especialmente las que comprometen el hueso temporal y pabellón auricular (por ejemplo, fisura labiopalatina).
- Peso de nacimiento menor de 1500 gramos.
- Prematurez.
- Puntuación Apgar 0 a 4 al minuto, o bien 0 a 6 a los 5 minutos.
- Hiperbilirrubinemia que requirió transfusión sanguínea.
- Historia familiar de hipoacusia sensorineural.
- Síndromes asociados a hipoacusia: neurofibromatosis, osteopetrosis, síndrome de Usher, Waardenburg, Alport, Pendred, Jervell y Lange-Nielson.
- Uso de ototóxicos (gentamicina o furosemida).
- Ventilación mecánica por más de 5 días.
- Distress respiratorio.
- Fractura del hueso temporal.
- Quimioterapia.

Se debe preguntar acerca de **antecedentes conductuales que permiten sospechar hipoacusia** en el niño o la niña:

0 a 3 meses	Se sobresalta con ruidos fuertes. Se despierta con algunos sonidos. Parpadea o abre los ojos en respuesta a los ruidos.
3 a 6 meses	Se tranquiliza con la voz de la madre. Detiene su juego cuando escucha sonidos nuevos. Busca la fuente de sonidos nuevos fuera de su alcance
6 a 9 meses	Disfruta juguetes nuevos. Gorjea. Dice disílabos o mamá.
9 a 12 meses	Responde a su nombre. Sigue órdenes simples. Utiliza vocabulario expresivo de 3 a 5 palabras.

CUADRO 4. Antecedentes conductuales ausentes asociados a hipoacusia

En niñas y niños menores de dos años, la evaluación audiológica se basa en la realización de emisiones otoacústicas que captan la energía generada por la cóclea en forma espontánea o en respuesta a un sonido externo (evocado) y potenciales evocados auditivos automatizados (la respuesta neuroeléctrica del sistema auditivo ante un estímulo sonoro). Estos exámenes permiten sospechar la presencia de patología en el oído interno y/o de la vía auditiva. En caso de estar alterado alguno de los exámenes anteriores, o presentar factores de riesgo, se deben solicitar potenciales evocados de tronco cerebral.

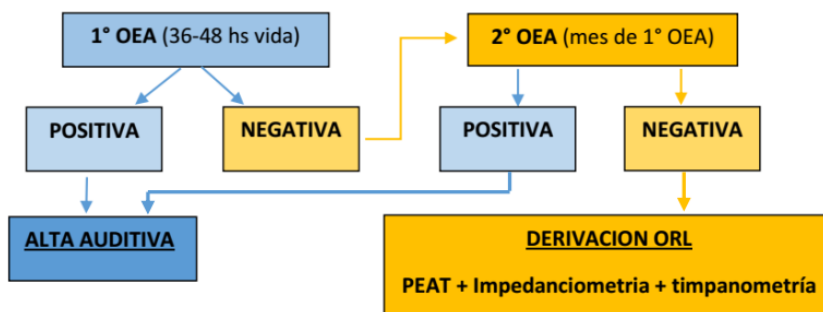


Gráfico 1: Algoritmo pesquisa auditiva en recién nacidos sanos ¹¹

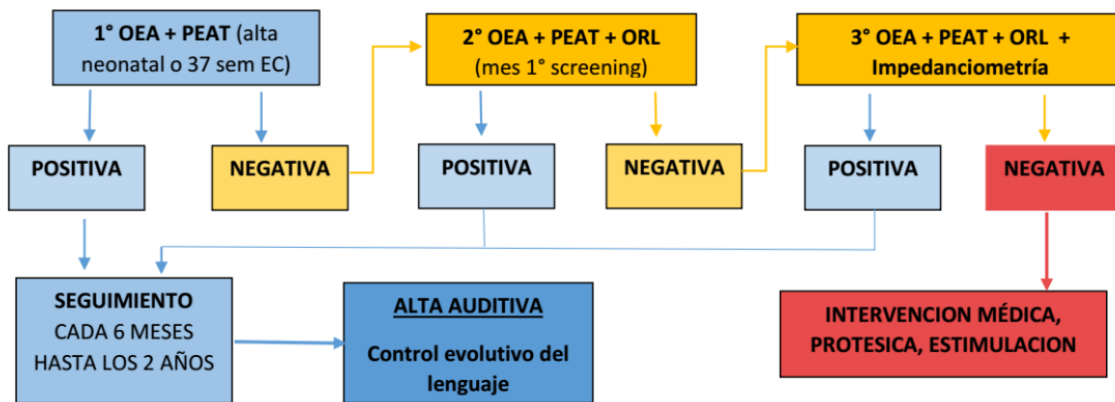


Gráfico 2: Algoritmo pesquisa auditiva en recién nacidos con factores de riesgo ¹¹

Bibliografía

1. Tellez A. «La Consulta Pediátrica: Una Oportunidad», de Pediatría Ambulatoria: Un enfoque Integral, Santiago, Ediciones UC, 2011, pp. 21-24.

2. Programa Nacional Chileno de salud en la infancia “Norma técnica para la supervisión de niños y niñas de 0-9 años en la atención primaria de salud”. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. 2014.

3. L. Manfredi, A. M. Speranza, A. Giannini, N. Corso. "Guía de atención primaria de la salud, control de salud del niño durante el primer año de vida". Área de Salud Integral del Niño. Boletín Remediar Atención Primaria de La Salud. Dirección Nacional de Salud Materno-infantil. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, 2005, Vol. 3 N° 19 págs 14-17.
4. P. Valenzuela y R. Moore, «Supervisión de Salud: Un Enfoque Integral,» de Pediatría Ambulatoria: Un enfoque integral, Santiago, Ediciones Universidad Católica, 2011, pp. 15-20.
5. Comité Nacional de Hematología. "Anemia Ferropénica. Guía de diagnóstico y tratamiento". Arch Argent Pediatr 2009; 107(4):353-361.
6. Mandredi L; Speranza Ana M; Giannini Alicia; Corso Nora. "Lactancia Materna". Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Boletín Remediar Atención Primaria de La Salud. Vol. 3 N° 19 págs. 18-21.
7. Guía Lactancia Materna. UNICEF. Honduras. 2012.
8. Lactancia, Promoción y Apoyo en un Hospital Amigo de la Madre y del Niño. Módulo 3. Ministerio de la Salud de la Nación, Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS). 2013.
9. Pesquisa endocrino-metabólica. Programa Nacional de Fortalecimiento de la Detección Precoz de Enfermedades Congénitas. Ministerio de Salud de La Nación. 2011.
10. Ley Nacional 25415. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
11. Pesquisa Neonatal Auditiva. Programa Nacional de Fortalecimiento de la Detección precoz de Enfermedades Congénitas. Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Ministerio de Salud de la Nación. 2014.

